جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ياسمين جمال حسن سطوحي
المحافظة : القليوبيه **الحي / المدينة :** شبرا الخيمه ثان **العنوان :** 0
رقم البطاقة : 28808061401426 **رقم التليفون :** 01012195128 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 24-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 06-08-1988 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ياسمين جمال حسن سطوحي
National ID: 28808061401426

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



ياسمين
جمال حسن سطوحى
٣٠ ش محمد الغنام-ارض التراب
شبرا الخيمة ثان - القليوبية

٢٨٨٠٨٠٦١٤٠١٤٢٦

JY4454734

٢٨٨٠٨٠٦١٤٠١٤٢٦ ٢٠٢٣/٠٤
عاملة زراعية

انثى مسلمة متزوجة
محمود جمال محمود ابوخزيم
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٤/٠٧

١

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

البنك المصرية هي صحة مصر

(٠٥٢) MDT FORM ٠١٠٦٥١٠١٢٩٥

2/6/2022

Name	ياسمين جمال حسن سطوحي	MRN	٢٠٠١/٣٨٩٢
		ID	٢٨٨٠٨٠٦١٤٠١٤٢
Age	33 yrs ♀	Phone	
Menopausal status		marital status	
OCP		Family history	
Co morbidity			

Clinical Data

Bx: IDC L CT4b-N1

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
8/8	4/8	3+	

Sonomammography: ITMRM

No residual tumour tissue

Mets Workup: free nipple & areola free deep margin

R/ NAC AC x4 + THP x4 cycles

0 ~~POR~~ 1

TNM

Recommendations:

+ meta static deposits in 1/10 LN

pathological partial response

4PTo 4PN1

MDT OUTCOME & PLAN

in view of Partial pathological Respon (ypTo-4pN1) for

Rx Kadcyla. / 14 cycles.

/ AI + zoladex. (proka 16 m).

/ PORT

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	SIGNATURE RADIOLOGY	PATHOLOGY

(٠٢٢) ٦١٢

Name: ياسمين جمال حسن سطوحي **MR. :** 2611	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was diagnosed with triple-positive breast cancer (TPBC) staged T4b N1. Neoadjuvant chemotherapy (NACT) was administered followed by a left total mastectomy with reconstruction (LT MRM). Pathology after surgery indicated ypT0 N1 with a partial pathological response (PPR) in 2022. The current systemic regimen includes ADK KADCYLA, an aromatase inhibitor (AI) combined with zoledronic acid (ZOL) and a port placed today for administration of arimidex. Staging imaging performed includes a non-contrast chest CT (NCCT CHEST), bilateral breast ultrasound (BR US), and an abdominal-pelvic ultrasound (APUS).

The patient continues on arimidex, zoledronic acid (zometa), and zoladex, with supportive treatment; laboratory studies obtained outside the institution have been accepted.

تحريرا في ,

التاريخ :	21-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر

يعتمد ,

Patient name: Yasmin Gamal Hassan Setouhy

Date: 16/4/2022

Bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indications:

Post-neoadjuvent follow up

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are scattered fibroglandular densities (ACR B)
- Left UOQ pleomorphic microcalcifications of segmental distribution measuring 7.9x5.6 cm, reaching to the nipple, with overlying skin thickening reaching 0.42 cm. US showed 2:00 ill-defined hypoechoic solid lesion measuring 1.2x0.7 cm, harboring internal echogenic shadowing foci, with ductal extension toward the nipple through dilated ducts harboring echogenic shadowing foci.
- No right suspicious microcalcifications or spiculated masses
- Complementary ultrasound shows no right solid or cystic masses along with dilated retroareolar ducts reaching 0.5 cm in caliber with internal clear contents.
- Normal right skin thickness, and nipple-areola complex.
- Right non-specific axillary LN.
- Left prominent axillary lymph node showing focal cortical thickening reaching 0.27 mc and preserved hilum

Opinion:

- Right retroareolar duct ectasia (BIRADS 2)
- Left UOQ malignant microcalcifications as described above, with partial response of UOQ lesions, and partial response of left axillary lymph node (BIRADS6)

Yours truly,

Dr. Yasmin Nada

National Women's Health Initiative Pathology Lab

Patient Name	:	Request No.	: 137942
Patient No	: 2880809' 401426	Request Date	: 02/10/2021
File No	: SR-501/2	Verification Date	: 03/10/2021
Sex	: Female	Financial Category	:
Age	: 53 Y	Department	: Out Patient
Referring Doctor		IHC No.	:

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:
Left breast mass

Status of the specimen:
Slide revision

Gross Examination:
Block (3756/21) & 3 slides

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade II
- Lymphovascular invasion: No
- Ductal carcinoma in situ: No
- Lymph node involvement: N/A
- Resection Margins: N/A

Diagnosis:
Left breast mass; Slide revision:
Invasive ductal carcinoma grade II

IHC:
ER: Strong nuclear reaction in more than 70% of tumour cells. Positive score (8/8)
PR: Strong nuclear reaction in about 60% of tumour cells. Positive score (7/8)
HER2: Strong complete membrane reaction in 10% of tumour cells. Positive score 3+

Prof. Dr. Fatma El Abd-El Aty
Dr. Abdelrahman Ibrahim

Printed On: 03/10/2021 17:16:32 Page 1 of 2 Printed By : abdelrahman ibrahim

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	: الأستاذه / ياسمين جمال حسن سطوحي	Request No.	: 13002792
Patient No.	: 28808061401426	Request Date	: 12/05/2022
Path No.	: 1227/22	Verification Date	: 24/05/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 33 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

- Pathologic partial response
- Stage : ypT0 , ypN1

Dr.Menna Nabil

Prof.Dr . Gamal Abdelatty

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Med. Record No.:	2021165065
Patient Name:	YASMEN GAMAAL HASSAN Setohy
Sex:	Female DOB: 8/6/1988
Nationality:	EGYPTIAN
Unit:	External Clinic

IMMUNOPATHOLOGY - Final Anatomical Diagnosis

Her2 Receptors

Specimen Id 2109010212
Accession No IMM21-5663
Collection Date 9/1/2021 11:25:42AM
Receive Date 9/1/2021 11:25:56AM
Sample Type Paraffin Block
Requesting Doctor Abd ALLAH Mohamed Gamil

Immunohistochemical Report

pathology number

8756/21

Clinical Data

LT breast cancer.

Gross Picture :

Referred block submitted for HER 2 immunostaining.

System Used :

Ventana BenchMark ULTRA autostainer.

Antibody:

Ventana anti-HER-2 (4B5) rabbit monoclonal antibody.

Scoring system :

Reference: ASCO–CAP HER2 Test Guideline Recommendations, 2018. IHC 0 :as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within <=10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within >10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: The revised definition of IHC 2+ (equivocal) is weak to moderate complete membrane staining observed in >10% of tumor cells.. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense in >10 % of tumor cells.

(Laterality) breast Cancer:

left

Her2 Result - 1

Positive [score 3+]

Signature

MAHITAB IBRAHIM MOHAMED PHD

Patient Name	: الأستاذه / ياسمين جمال حسن سطوحى	Request No.	: 13002792
Patient No.	: 28808061401426	Request Date	: 12/05/2022
Path No.	: 1227/22	Verification Date	: 24/05/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - تغطة الدولة
Age	: 33 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer post NACT

Nature of the specimen: Left breast + Left axillary L.Ns

Gross Examination:
- Procedure:Left breast specimen measured 19x17x6 cm ,skin covering ellipse measured 22x10 cm .
- Localization: UOQ
- Tumor extent: A rubbery greyish white TBS .
- Size: 2.3 x2 cm
- Skin involvement: Nipple and areola were unremarkable grossly .
- Distance from margins: 2.5 cm away from deep margin
- Lymph nodes number and size: 10 Nodules up to 0.9 cm .

Microscopic examination:
- Histological type: No residual of tumour tissue
- Skin involvement: Free Nipple and areola
- Lymph node involvement: Positive metastatic deposits in one lymph node (1/10). one lymph node showed macrometastasis and one showed isolated tumour cells
- Resection Margins: Free deep margins
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response.

Diagnosis:
Left breast cancer . Left breast + Left axillary L.Ns :
- No residual of tumour tissue
- Free nipple and areola
- Free deep margins
- Positive metastatic deposit in one Lymph node (1/10)

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

PATIENT NAME: **YASMEN GAMAAL HASSAN** Setohy GENDER: Female AGE: 33 y	PATIENT ID #: **2021165065** ORDER #: **1218091,1218092** DATE OF SERVICE: **11-Sep-2021 04:12 PM**

Report: - all studies

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS WITH TRIPHASIC STUDY OF THE LIVER REVEALED:

(I) Chest:

- Left multiple enhancing masses associated with overlying skin thickening, the largest seen measuring about 22x20mm.
- Multiple pathologically enlarged left axillary (level I) lymph nodes, the largest seen measuring about 14x12 mm.
- Both lung fields are clear showing no parenchymal nodules, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is increased in size showing homogenous CT density and enhancement with no focal lesions.
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys(apart from tiny left upper cortical simple cyst), aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- IUD is seen insitu. Bilateral adnexal cysts are noted, otherwise no gross uterine or adnexal abnormality or solid masses.
- Multiple enlarged mesentric lymph nodes are seen, one of them shows dense calcification, likely sequel of old granulomatous infection.
- No ascites.
- The examined bony skeleton shows no lytic or sclerotic lesions.

OPINION:

- **Left breast masses associated with pathological ipsilateral axillary lymph node.**
- **No current CT evidence of distant pulmonary or hepatic**

PATIENT NAME: **YASMEN GAMAAL HASSAN Setohy** GENDER: **Female** AGE: **33 y**	PATIENT ID #: **2021165065** ORDER #: **1218093** DATE OF SERVICE: **15-Sep-2021 01:12 PM**

Report:

99mTc-MDP BONE SCAN

Desired Information :- skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 minutes & 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99mTc-MDP :

Findings:-

Warm tiny uptake at the right humeral shaft and sternal body for close follow up.

Degenerative changes at dorso- lumbar vertebrae.

Arthritic changes at knees and shoulders.

Both kidneys are seen.

Conclusion:-

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Recommendation

Close follow up bone scan after 3 months is highly advised.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed 16-Sep-2021 09:30 AM

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Yasmin Gamal Hassan Settohi	Date : 06/02/2023
Exam : sufer licial u/s	Age : 34 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 14995

Soft tissue ultrasound examination of left chest wall -

- *MRM*
- *Mild subcutaneous interstitial edema with fibrotic changes*
- *No solid or cystic lesions*
- *No evidence of pathologically enlarged axillary LNs*
- *Normal vascular structure*

Signature Dr . Nermien Ramadan

06/02/2023 11:59 AM